

Rx MAGNESI SULFAT KABI 15%

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Thành phần công thức:

Mỗi ống 10 ml dung dịch chứa:

Thành phần hoạt chất: Magnesi sulfat 1,5 g.

Thành phần tá dược: Nước cất pha tiêm vừa đủ.

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm

Dung dịch trong, không màu, đóng trong ống thủy tinh không màu 10 ml, hàn kín.

pH: 5,5 – 7,0

Chỉ định:

Điều trị ngừng tim do xoắn đỉnh (TdP).

Điều trị hạ kali cấp tính liên quan đến hạ magnesi huyết.

Bổ sung magnesi trong quá trình tái cân bằng các chất điện giải.

Bổ sung magnesi trong chế độ nuôi ăn qua đường tĩnh mạch.

Phòng và điều trị sản giật.

Liều dùng, cách dùng:

Liều dùng:

Điều trị ngừng tim do xoắn đỉnh (TdP):

Tiêm liều nạp đường tĩnh mạch 8 mmol cation magnesi tức là tiêm tĩnh mạch chậm 2 g magnesi sulfat, sau đó truyền tĩnh mạch liên tục từ 0,012 đến 0,08 mmol cation magnesi/phút tức là từ 3 đến 20 mg/phút magnesi sulfat).

Điều trị hạ kali cấp tính liên quan đến hạ magnesi huyết:

Truyền tĩnh mạch từ 24 đến 32 mmol cation magnesi tức là từ 6 đến 8 g magnesi sulfat/24 giờ. Việc bổ sung kali phải được thực hiện bằng bộ truyền khác với magnesi.

Ngừng điều trị khi nồng độ magnesi đạt mức bình thường.

Bổ sung magnesi trong quá trình tái cân bằng các chất điện giải và trong nuôi ăn qua đường tĩnh mạch:

Truyền tĩnh mạch 6 - 8 mmol cation magnesi trong 24 giờ, tức là 1,5 g đến 2 g magnesi sulfat.

Ở trẻ em, liều thông thường là 0,1 đến 0,3 mmol/kg cation magnesi, tức là 25 - 75 mg/kg magnesi sulfat trong 24 giờ.

Phòng và điều trị sản giật:

Để ngăn ngừa sản giật hoặc điều trị khi xuất hiện phản ứng này, truyền tĩnh mạch 16 mmol cation magnesi tức là 4 g magnesi sulfat trong 20 đến 30 phút.

Trong trường hợp sản giật vẫn còn tiếp diễn, truyền tĩnh mạch thêm 16 mmol cation magnesi tức là 4 g magnesi sulfat mà không vượt quá liều tích lũy tối đa 32 mmol cation magnesi tức là 8 g magnesi sulfat trong suốt giờ điều trị đầu tiên.

Sau đó, truyền liên tục từ 8 đến 12 mmol cation magnesi tức là từ 2 đến 3 g magnesi sulfat mỗi giờ trong 24 giờ sau cơn co giật cuối cùng.

Bệnh nhân suy thận: Cần phải giảm liều thích hợp.

Cách dùng:

Tiêm tĩnh mạch chậm,

Truyền tĩnh mạch, pha loãng trong dung dịch glucose hoặc nước muối sinh lý.

Chống chỉ định:

Quá mẫn với magnesi sulfat hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Bệnh lý não gan, suy gan.

Suy thận nặng (creatinin < 30 ml/phút/1,73m²).

Nên tránh tiêm magnesi sulfat ở những bệnh nhân bị phong bế tim.

Khuyến cáo không dùng kết hợp thuốc với quinidin.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

Cần thận trọng khi tiêm magnesi cho những người bị nhược cơ, để ngăn ngừa sự trầm trọng của tình trạng này hoặc cơn nhược cơ cấp. Cần đánh giá lợi ích/nguy cơ ở từng bệnh nhân trước khi bắt đầu điều trị.

Không nên sử dụng magnesi sulfat cho bệnh nhân hôn mê gan nếu có nguy cơ bị suy thận.

Cần theo dõi nồng độ calci huyết thanh thường xuyên ở những bệnh nhân dùng magnesi sulfat.

DUNG DỊCH ƯU TRƯỚC CẦN TIÊM CHÂM.

· Các lần tiêm tĩnh mạch đầu tiên phải được thực hiện trong bệnh viện.

· Tuân thủ với tốc độ truyền không quá 0,6 mmol cation magnesi mỗi phút hoặc 150 mg/phút magnesi sulfat heptahydrat.

· Theo dõi huyết áp khi tiêm tĩnh mạch và truyền liên tục.

· Giám sát magnesi; ngừng điều trị ngay khi magnesi được bình thường hóa.

· Giảm liều ở người suy thận cùng với tăng cường theo dõi chức năng thận, huyết áp và magnesi huyết.

· Không dùng chung với muối calci (tác dụng đối kháng).

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Phụ nữ có thai:

Về mặt lâm sàng, việc sử dụng magnesi trong một số lượng giới hạn các trường hợp mang thai rõ ràng cho thấy không có tác dụng gây dị tật hoặc ảnh hưởng lên thai nhi cụ thể nào cho đến nay. Tuy nhiên, cần có những nghiên cứu sâu hơn để đánh giá hậu quả của việc phơi nhiễm trong thai kỳ.

Do đó, việc sử dụng magnesi chỉ nên được xem xét trong thời kỳ mang thai nếu thật cần thiết.

Phụ nữ cho con bú:

Do thiếu các dữ liệu chứng minh, tốt nhất không nên cho con bú khi đang điều trị bằng magnesi sulfat.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc:

Hiện chưa có dữ liệu nghiên cứu về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác, tương kỵ của thuốc:

Tương tác thuốc

Thuốc giãn cơ: muối magnesi đường tiêm làm tăng tác dụng các thuốc giãn cơ không khử cực như tubocurarin.

Các thuốc chẹn kênh calci như nifedipin hoặc nimodipin hiếm khi dẫn đến sự mất cân bằng ion canxi và có thể dẫn đến bất thường chức năng cơ. Hạ huyết áp sâu đã được ghi nhận ở hai phụ nữ được uống nifedipin.

Cần thận trọng khi sử dụng muối magnesi cho những người đang điều trị với glycosid tim. Việc sử dụng muối magnesi đường tiêm có thể làm tăng tác dụng của thuốc phong bế thần kinh cơ hoặc các chất ức chế thần kinh trung ương.

Các thuốc ức chế thần kinh trung ương: Khi dùng barbiturat, opiat, thuốc gây mê toàn thân, hoặc các thuốc ức chế hệ thần kinh trung ương khác cùng với magnesi sulfat, liều lượng của các thuốc này phải được điều chỉnh cẩn thận vì các tác dụng ức chế thần kinh trung ương.

Các tác nhân kháng khuẩn: Tác dụng phong bế thần kinh cơ của magnesi đường tiêm và các kháng sinh aminoglycosid có thể được tăng lên.

Magnesi có thể gây ra tác dụng ức chế thần kinh cơ nghiêm trọng và không thể đoán trước.

Sử dụng magnesi có thể giúp làm giảm các tác động kích thích cơ khi bị ngộ độc bari.

Tương kỵ:

Magnesi sulfat có thể pha vào dung dịch glucose 5% hoặc natri clorid 0,9%. Magnesi sulfat không được pha vào mannitol, máu hoặc các sản phẩm máu, hoặc dung dịch chứa aminoacid hoặc có chứa lipid, vì có thể làm kết tủa những chất này hoặc gây tan hồng cầu truyền vào. Magnesi sulfat còn tương kỵ với calcium gluceptat, dobutamin HCl, polymyxin B sulfat, procain HCl, và natri bicarbonat.

Tác dụng không mong muốn:

Ở những bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận, việc tích tụ magnesi có thể gây độc.

Việc sử dụng magnesi quá mức dẫn đến tăng magnesi huyết. Các triệu chứng tăng magnesi huyết có thể bao gồm buồn nôn, nôn mửa, đỏ bừng da, khát, hạ huyết áp do giãn mạch ngoại vi, buồn ngủ, lú lẫn, mất phản xạ gân và suy hô hấp do phong bế thần kinh cơ, nhược cơ, suy hô hấp, loạn nhịp tim, hôn mê và ngừng tim.

Phản ứng quá mẫn. Giảm calci huyết.

Quá liều và cách xử trí:

Các dấu hiệu đầu tiên của chứng tăng magnesi huyết là ức chế phản xạ bánh chè, người nóng bừng, buồn ngủ, rối loạn ngôn ngữ, liệt cơ kèm theo khó thở, và hay gặp nhất là ngừng hô hấp và tim.

Điều trị:

- Bù nước, bài niệu cưỡng bức,
- Tiêm tĩnh mạch 1 g calci gluconat,
- Thẩm phân phúc mạc hoặc thẩm phân máu cho bệnh nhân suy thận.

Các đặc tính dược lực học:

Phân loại dược lý: Dung dịch điện giải magnesi sulfat, mã ATC: B05XA05 (B: máu và cơ quan tạo máu).

Về mặt sinh lý:

Magnesi chủ yếu là cation nội bào, làm giảm tính hưng phấn của tế bào thần kinh và dẫn truyền thần kinh cơ.

Magnesi can thiệp vào nhiều phản ứng enzym.

Magnesi là một yếu tố cấu thành: 50% của magnesi nằm chủ yếu ở cấp độ xương.

Lâm sàng: *Magnesi huyết:*

- 12 đến 17 mg/l (1 đến 1,4 mEq/l hoặc 0,5 đến 0,7 mmol/l), cho thấy sự thiếu hụt magnesi vừa phải;
- dưới 12 mg/l (1 mEq/l hoặc 0,5 mmol/l), cho thấy thiếu magnesi nghiêm trọng.

Sự thiếu hụt magnesi có thể là:

- bất thường chuyển hóa bẩm sinh (chứng giảm magnesi huyết bẩm sinh mạn tính).
- thứ phát bởi:
 - + lượng hấp thu không đủ (suy dinh dưỡng nghiêm trọng, nghiện rượu, chế độ ăn uống hoàn toàn qua đường tĩnh mạch),
 - + kém hấp thu ở đường tiêu hóa (tiêu chảy mạn tính, lỗ rò tiêu hóa, suy tuyến cận giáp),
 - + Suy giảm chức năng thận quá mức (bệnh ống thận, đa niệu đáng kể, lạm dụng thuốc lợi tiểu, viêm thận bể thận mạn tính, tăng aldosteron huyết nguyên phát, điều trị bằng cisplastin).

Các biểu hiện lâm sàng không đặc hiệu có thể xảy ra khi thiếu magnesi là run, yếu cơ, cơ uốn ván, mất điều hòa, tăng phản xạ, rối loạn tâm lý (cáu kỉnh, hồi hộp, mất ngủ ...), rối loạn nhịp tim (ngoại tâm thu, nhịp tim nhanh), rối loạn tiêu hóa (tiêu chảy ...).

Các đặc tính dược động học:

Nồng độ magnesi trong huyết tương thường nằm trong khoảng 0,75 - 0,95 mmol/l.

Một lượng nhỏ không đáng kể magnesi được bài tiết trong sữa mẹ. Đường thải trừ chủ yếu của magnesi là qua thận, magnesi đường uống hay đường tiêm đều thải trừ nhanh theo con đường này. Trong trường hợp bị suy thận có thể gây tích tụ magnesi.

Khả năng bị ngộ độc magnesi cao hơn khi dùng đường tiêm so với dùng đường uống.

Ở nồng độ magnesi huyết lên đến 4 mmol/l, tác dụng phụ duy nhất có thể quan sát được là đỏ bừng da do giãn mạch ngoại biên. Ở nồng độ khoảng 4 - 5 mmol/l, độc tính xảy ra trước hết là mất phản xạ vùng gân sâu, sau đó là hạ huyết áp, nhịp tim chậm và cuối cùng là sự phong tỏa thần kinh cơ dẫn đến ngừng hô hấp.

Khi tiêm tĩnh mạch, magnesi sulfat có tác động ngay lập tức, và thời gian tác dụng là khoảng 30 phút.

Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 10 ml. Hộp 50 ống x 10 ml.

Điều kiện bảo quản:

Bảo quản ở nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Tiêu chuẩn chất lượng: BP

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất:

Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam

Khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam